

Faringoamigdalite · viral × estreptococo

Maioria é viral. Trate estreptococo do grupo A para abreviar sintomas e prevenir febre reumática — use critérios + teste quando disponível.

Clínica de SGA

Dica - Clínica de SGA

Febre, dor de garganta, exsudato, adenomegalia cervical dolorosa, ausência de tosse/coriza.

Petéquias de palato e rash escarlatiniforme reforçam.

Evite ATB 'por precaução' em coriza/tosse — padrão viral.

Faringite pediátrica

Clinica -> teste -> ATB se SGA



Conduta

- 1ª linha: penicilina V ou amoxicilina; benzatina se adesão duvidosa
- Alergia não anafilática: cefalosporina; anafilaxia: macrolídeo/clinda conforme guia
- Retorno escolar após 24 h de ATB se afebril
- Abscesso peritonsilar: voz abafada, trismo — drenagem + ATB

Viral × bacteriana

Pista | Viral | SGA

Coriza/tosse | Comum | Rara

Exsudato | Variável | Frequente

Idade <3 anos | Mais viral | SGA menos típico

ATB | Não | Sim se confirmado/alta probabilidade

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Não use amoxicilina empírico em mononucleose suspeita (rash). Em faringite + dificuldade respiratória, pense epiglotite/abscesso — via aérea primeiro.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1